子宮内膜 FFPE 検体を用いた PCR 検査により診断確定に至った結核性子宮内膜炎の一例

◎大澤 明弘[1)]、平野 康智[1)]
地方独立行政法人 岐阜県総合医療センター[1)]

不妊症や習慣性流産の原因として、結核性子宮内膜炎は稀ではあるものの鑑別すべき疾患の一つである。子宮内膜 FFPE 検体を用いた PCR 検査により診断確定に至った結核性子宮内膜炎の一例について報告する。

32 歳、女性。X-２年、感冒を契機に左胸水を指摘され、当院呼吸器内科を受診。T-SPOT 陽性、非結核性抗酸菌抗体(MAC)陽性のため、肺結核を疑い、抗酸菌連続三回喀痰試験（三連痰）を予定するも、喀痰採取困難で中止。肺炎随伴胸水、膿胸への治療により、症状の改善が認められたため、無治療経過観察とした。

X 年、高度生殖補助医療(ART)で妊娠成立し、近医で定期健診を受けていた。妊娠 12 週、性器出血と子宮頚管長の短縮を認め、当院産婦人科紹介受診。切迫流産の診断で緊急入院となった。妊娠 16 週、胎盤辺縁に血腫の形成を認め、性器出血および子宮収縮の増加を認めることから、妊娠継続困難と判断され、妊娠 17 週、流産となった。

産後 3 か月、慢性子宮内膜炎の評価目的に子宮内膜組織診を実施した。組織学的に、高度の炎症細胞浸潤とともに、多核巨細胞を含む類上皮肉芽腫の形成を認めるものの、この時点では、Ziehl-Neelsen 染色で抗酸菌を確認できなかった。既往歴と病理組織学的所見から、結核性子宮内膜炎の可能性を考慮し、FFPE 検体にて PCR 検査を行った。Mycobacterium tuberculosis と一致する塩基配列を認め、結核菌による子宮内膜炎の可能性が高いと考えられた。PCR 検査結果を受け、再度標本の確認を行ったところ、数個の抗酸菌を認めたことより、結核性子宮内膜炎の診断が確定した。

結核性子宮内膜炎は稀な疾患であり、検査前には、結核の関与を強くは疑っていなかったため、細菌学的検査は未実施であった。病理組織検索において、抗酸菌染色のみでは感度が低く、また菌種同定が困難である。このような症例では、FFPE 検体を用いた PCR 検査が M. tuberculosis の診断に有用である。

岐阜県総合医療センター　病理部
058-246-1111（内線 7819）